

Deficit Intellettivo — Sintesi

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 07

Tre criteri, una rete di sostegni, una persona al centro. Tienilo a mente e il resto viene da sé.

Definizione e tre criteri diagnostici (AAIDD 2022)

Per fare diagnosi di **Deficit Intellettivo (DI)** devono coesistere tutti e tre:

- **Funzionamento intellettivo** significativamente limitato → $QI < 70$ (≥ 2 deviazioni standard sotto la media)
- **Comportamento adattivo** significativamente limitato → almeno 2 DS sotto la media in uno dei tre domini (concettuale, sociale, pratico)
- **Origine nel periodo dello sviluppo** → prima dei 22 anni (esclude la demenza)

Se manca anche uno solo dei tre criteri, la diagnosi non è possibile.

A. Funzionamento intellettivo

- Più ampio di "intelligenza": include pensiero, apprendimento, ragionamento, pianificazione, imparare dall'esperienza
- Misurato con test standardizzati (**QI**): media = 100, deviazione standard = 15
- Soglia diagnostica: **QI < 70** (oggi; in passato era 75)
- Il 2,3% della popolazione ha $QI < 70$, ma solo l'**1–1,5%** riceve diagnosi di DI (perché serve anche il criterio del comportamento adattivo)
- Il QI da solo dice poco: il profilo funzionale è più utile nella pratica educativa

Storia: Binet e il QI

- **1904**: il ministero francese incarica una commissione — Binet costruisce la prima scala di valutazione (30 problemi graduati per età)
 - **1905**: pubblicazione della **Scala Binet-Simon**; Binet = padre della **psicometria**
 - Il **QI** (Quoziente Intellettivo) è poi il rapporto (età mentale / età cronologica) × 100, introdotto da **Stern**
 - Oggi: scala **Stanford-Binet** e test **Wechsler**; il calcolo è molto più complesso
 - Attenzione: test somministrati in lingua non madre o senza discriminanti culturali danno risultati distorti (errore storico con la popolazione afroamericana negli USA)
-

B. Comportamento adattivo

- Insieme di abilità concettuali, sociali e pratiche per il funzionamento quotidiano
- È **evolutivo** (cresce con l'età) e legato agli ambienti tipici per l'età
- Valutato sulla prestazione **tipica**, non sulla migliore

Dominio	Esempi di limitazioni
Concettuale	Pianificazione, pensiero astratto, uso di simboli (tempo, denaro), lettura/scrittura
Sociale	Giudizio sociale, suggestionabilità, rischio vittimizzazione, desiderio di compiacere l'autorità
Pratico	Cura di sé, gestione domestica, lavoro, uso del denaro, sicurezza ambientale

C. Età di esordio

- Prima dei **22 anni** (arbitrario — serve a distinguere DI da demenza)

- La maggior parte delle diagnosi: **prima infanzia**
-

Terminologia

- **Deficit intellettivo** = termine corretto oggi (sostituisce "ritardo mentale")
 - **"Ritardo mentale"** = obsoleto e fuorviante — non usarlo
 - **Disabilità cognitiva** = termine più ampio: include DI, disturbi dell'apprendimento, ADHD, difficoltà percettive sensoriali. Non tutte le disabilità cognitive sono DI.
-

Classificazione per intensità

Livello	QI	Sostegni
Gravissimo	0–20/25	Continuo
Grave	20/25–40/45	Estensivo
Medio/medio-grave	40/45–55	Limitato
Leggero/lieve	55–70/75	Intermittente

Il prof sottolinea che la classificazione per QI è imprecisa nella pratica — meglio classificare per **intensità del bisogno di sostegno**.

Prevalenza e cause

- **1–1,5%** della popolazione mondiale (DSM-5)
 - Cause: alterazioni embrionali precoci (30%), gravidanza/parto (10%), ereditarietà (5%), malattie (5%), cause ambientali (15–20%), **causa sconosciuta (30–40%)**
 - Fattori di rischio: malnutrizione materna, alcol (anche piccole dosi → Sindrome Alcolica Fetale), droghe, prematurità, ipossia, deprivazione sociale post-nascita
-

I Sistemi di Sostegno

- Diagnosi e classificazione servono a costruire un **profilo di sostegni necessari**
- Con sostegni adeguati, personalizzati e prolungati, il funzionamento **tende a migliorare** (non scompare la disabilità, ma ne diminuisce l'impatto)

Caratteristiche dei sistemi efficaci (AAIDD 2022)

- **Centrati sulla persona** — desideri, bisogni, aspettative al centro
- **Completi** — coprono tutti i contesti di vita
- **Coordinati** — qualcuno gestisce la rete
- **Orientati agli esiti** — impatto misurabile nella quotidianità

Tipologie di sostegno

- **Naturali**: famiglia, amici, comunità, tecnologia, ambienti inclusivi
- **Specialistici**: operatori sociali, terapeuti, didattica speciale, sensibilizzazione pubblica

Due concetti chiave

- **Scaffolding** (Wood, Bruner, Ross 1976): sostegno come impalcatura — orienta senza sostituirsi; si toglie quando la persona non ne ha più bisogno
- **ZSP di Vygotskij**: i sostegni vanno calibrati e aggiornati con l'evoluzione della persona — non restare fissi sullo stesso intervento per anni

Strumento: SIS

- **Supports Intensity Scale** (Thompson et al., 2004; standardizzazione italiana Cottini et al., 2008): misura l'entità dei sostegni necessari per attività adatte all'età in ambienti comunitari

Da ricordare:

Il DI si diagnostica con 3 criteri insieme (QI + comportamento adattivo + periodo di sviluppo). **Il QI da solo non basta** — né per diagnosi né per intervento. **I sostegni non eliminano la disabilità, ma fanno la differenza sulla qualità di vita.**